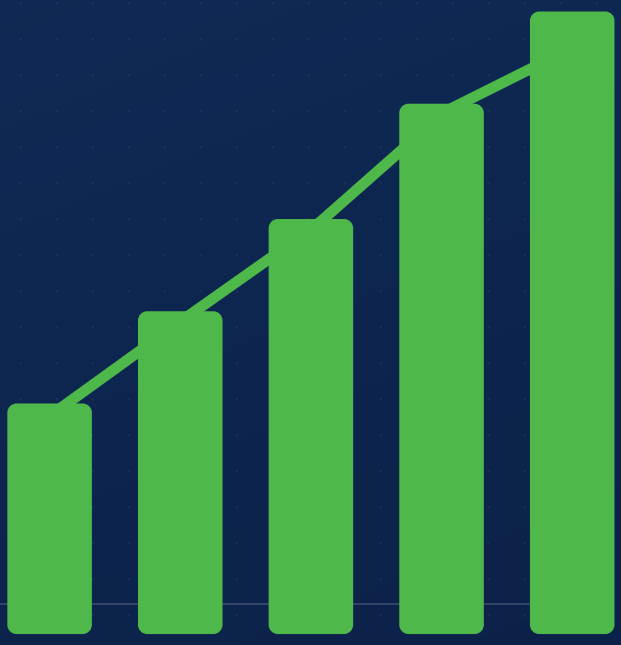
EBOOK PANDUAN

Panduan Komite Farmasi dan Terapi Menyusun Formularium Rumah Sakit Sesuai Permenkes 6/2026

Susun dan revisi formularium obat rumah sakit sesuai standar PKPO Permenkes 6/2026 lewat panduan kerja Komite Farmasi dan Terapi.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

B A B 1

Peran Komite Farmasi dan Terapi dalam Standar PKPO

KFT bukan sekadar rapat berkala yang dihadiri dokter dan apoteker. Dalam struktur mutu kefarmasian rumah sakit pasca Permenkes 6/2026, posisi KFT menjadi pengendali utama: semua kebijakan pemilihan, penggunaan, dan evaluasi obat harus melewati komite ini. Standar PKPO menjadikan formularium sebagai dokumen hidup—bukan arsip mati yang direvisi setiap lima tahun.

Maka, memahami peran KFT bukan mulai dari “apa saja tugasnya”, tapi dari “di mana KFT berdiri secara struktural”. Secara sederhana, KFT berada di antara direksi (pengambil keputusan strategis), staf medis fungsional/SMF (pengusul kebutuhan klinis), dan instalasi farmasi (pelaksana logistik dan pelayanan obat). Jika tiga jalur ini tidak tersambung lewat KFT, formularium akan berjalan sendiri-sendiri: dokter menulis resep di luar formularium, farmasi kesulitan menolak karena tidak punya dasar kuat, dan mutu penggunaan obat tidak terpantau.

Langkah praktis untuk memetakan posisi KFT di RS Anda:

1. Cek SK Direktur tentang pembentukan KFT. Pastikan susunan anggota mencakup ketua (dokter), sekretaris (apoteker), perwakilan SMF utama, perawat, dan bagian mutu. Jika tidak ada SK terbaru, jadwalkan revisi di rapat pertama.
2. Petakan alur usulan obat baru: dari dokter pengusul → SMF → KFT → direksi. Pastikan tidak ada jalur pintas “minta tolong langsung ke farmasi” yang tidak tercatat.
3. Tentukan jadwal rapat rutin minimal 3 bulan sekali, dengan agenda tetap: evaluasi usulan, revisi formularium, tindak lanjut insiden obat.
4. Buat daftar dokumen kendali yang harus dipegang KFT: formularium terkini, notulen rapat, form evaluasi usulan, surat keputusan perubahan, serta SPO penggunaan obat.

> **Catatan: Jangan anggap KFT sebagai beban administratif. Di mata surveyor, KFT adalah bukti bahwa RS punya kendali klinis terhadap obat—bukan sekadar daftar harga.**

Salah satu sumber masalah yang sering muncul adalah formularium yang tidak diperbarui karena tidak ada mekanisme evaluasi berkala. Contoh nyata: RS X menerima temuan akreditasi karena formularium terakhir dicetak 2019, sementara ada 8 obat baru yang diusulkan dokter spesialis pada 2022 dan 2023, tetapi tidak pernah dibahas tuntas. Notulen rapat tidak rapi, form evaluasi tidak ada, dan keputusan direksi tidak terdokumentasi. Akibatnya, surveyor menganggap KFT tidak menjalankan fungsi pengendalian formularium.

Peran KFT dalam PKPO juga menuntut hal yang lebih dalam: formularium harus sinkron dengan SPO penggunaan obat di unit pelayanan. Artinya, setiap obat yang masuk formularium harus jelas indikasi, batasan peresepan, dan cara pemberiannya. Jika tidak, formularium hanya menjadi daftar stok, bukan instrumen mutu.

Jadi, bab ini bukan untuk menghafal teori. Ini titik awal: pastikan struktur, alur, dan dokumen dasar KFT sudah tertata. Bab selanjutnya akan membahas cara menyusun formularium dengan template yang siap pakai.

INTI BAB: KFT adalah pengendali formularium dan kebijakan penggunaan obat; sebelum menyusun template, pastikan posisi struktural, alur usulan, dan dokumen kendali KFT sudah berjalan dan terdokumentasi.

B A B 2

Menyusun Struktur Formularium Obat RS

Banyak KFT yang masih menganggap formularium sekadar daftar obat yang ditempel di dinding farmasi. Padahal, formularium adalah **dokumen hidup** yang harus bisa dibaca cepat oleh dokter, apoteker, perawat, sekaligus menjadi bukti telusur saat akreditasi. Kalau strukturnya acak-acakan, revisi berkala jadi lambat, usulan obat baru jadi tidak terarah, dan obat yang sudah tidak relevan tetap menumpuk.

Kabar baiknya: menyusun struktur formularium itu tidak sulit. Anda hanya perlu menetapkan **format dasar** yang konsisten dan **kategori obat wajib** yang jelas. Berikut langkah praktiknya.

Langkah Praktik Menyusun Struktur Formularium

1. Tetapkan kerangka formularium dalam 5 bagian utama.
Jangan langsung menulis daftar obat. Mulailah dari kerangka dokumen yang akan memudahkan navigasi dan revisi. Bagian-bagian ini wajib ada:

- **Halaman identitas RS & KFT** – nama RS, periode formularium, tanggal penetapan, tanda tangan ketua KFT.
- **Pendahuluan & kriteria pemilihan obat** – jelaskan dasar hukum (Permenkes 6/2026, Fornas), prinsip cost-effectiveness, dan alur usulan obat.
- **Daftar obat per kelas terapi** – diurutkan berdasarkan sistem organ atau kelas farmakologi (misal: analgesik, antibiotik, kardiovaskular). Ini inti formularium.
- **Indeks obat** – daftar alfabetis untuk pencarian cepat. Sering dilupakan, padahal sangat membantu dokter saat visite.
- **Lampiran** – berisi daftar obat high alert, obat yang dibatasi penggunaannya, dan obat program.

> **Tips: Gunakan format tabel sederhana untuk setiap entri obat: No. | Nama Generik | Bentuk Sediaan | Kekuatan | Restriksi | Keterangan. Tabel ini memudahkan pembaruan per item tanpa mengubah seluruh dokumen.**

2. Masukkan kategori obat yang wajib tercantum.
Formularium bukan hanya daftar obat yang tersedia, tetapi juga mencerminkan kebijakan klinis RS. Pastikan kategori berikut ada dan terpisah jelas:

1. **Obat Formularium Nasional (Fornas) yang wajib tersedia** – sesuai kelas RS dan jenis pelayanan.
2. **Obat esensial tambahan** – obat di luar Fornas tetapi dibutuhkan untuk pelayanan unggulan RS (misal onkologi, ICU).
3. **Obat high alert & LASA (Look-Alike Sound-Alike)** – beri penanda khusus (misal bold atau warna) untuk mencegah medication error.
4. **Obat program pemerintah** – seperti TB, HIV, KB, yang pengelolaannya mengikuti kebijakan nasional.
5. **Obat dengan restriksi penggunaan** – obat yang hanya boleh diresepkan oleh spesialis tertentu atau memerlukan persetujuan KFT (misal antibiotik cadangan, kemoterapi).
6. **Obat yang sedang dievaluasi atau diusulkan penghapusan** – status ini penting agar revisi berkala tidak menumpuk.

✅ Checklist kategori obat wajib:

- ☐ Obat Fornas sesuai kelas RS
- ☐ Obat esensial tambahan (di luar Fornas)
- ☐ Obat high alert & LASA
- ☐ Obat program pemerintah
- ☐ Obat dengan restriksi penggunaan
- ☐ Obat yang diusulkan masuk/keluar formularium

3. Tentukan status setiap obat secara eksplisit.

Jangan biarkan pembaca menebak. Di kolom “Keterangan” tabel formularium, tulis status: **Tetap**, **Baru**, **Dievaluasi**, atau **Diusulkan Hapus**. Ini akan sangat membantu saat rapat revisi berkala, karena KFT tinggal fokus pada item yang berstatus “Dievaluasi” atau “Diusulkan Hapus”.

4. Sinkronkan struktur dengan SPO penggunaan obat.

Setiap kategori obat di formularium harus terhubung dengan SPO terkait. Contoh: obat high alert harus merujuk ke SPO penyimpanan dan pemberian high alert; obat restriksi merujuk ke SPO persetujuan penggunaan antibiotik. Jika belum ada SPO-nya, tandai di formularium sebagai “SPO menyusul” dan jadwalkan pembuatannya. Ini yang dicek akreditasi.

5. Buat versi ringkas formularium untuk saku.

Selain dokumen lengkap, buat versi ringkas 1–2 halaman berisi daftar obat per kelas terapi tanpa detail sediaan. Bagikan ke semua dokter dan perawat. Ini mempercepat adopsi formularium dalam praktik sehari-hari.

Dengan struktur yang jelas, formularium tidak lagi menjadi dokumen mati. Setiap kali ada usulan obat baru, Anda tinggal membandingkan dengan kategori yang ada. Setiap kali ada obat yang jarang dipakai, Anda bisa langsung menandainya untuk evaluasi. Dan saat akreditasi, semua bukti telusur tersusun rapi.

INTI BAB: Formularium yang efektif memiliki kerangka 5 bagian (identitas, pendahuluan, daftar per kelas terapi, indeks, lampiran) dan mencantumkan 6 kategori obat wajib secara eksplisit dengan status setiap obat yang jelas.

BAB 3

Mekanisme Evaluasi Usulan Obat Baru

Setiap usulan obat baru dari dokter spesialis sering kali datang dalam bentuk nota singkat atau bahkan pesan lisan. Akibatnya, KFT kesulitan menilai urgensi, bukti klinis, dan dampak biaya secara adil. Bab ini memandu Anda membangun mekanisme evaluasi yang baku: form usulan terstruktur, alur kerja jelas, dan dokumentasi siap audit.

Sebelum menerima usulan apa pun, pastikan pengusul sudah mengisi formulir yang memuat minimal elemen berikut:

> ✅ **Checklist Kelengkapan Usulan Obat Baru: Nama generik dan merek dagang (jika ada), bentuk sediaan & kekuatan, indikasi yang diminta, alasan klinis spesifik (misal: resistensi terhadap obat existing, efek samping lebih rendah), bukti pendukung (minimal 1 guideline nasional/internasional atau 2 jurnal peer-review ≤5 tahun), perbandingan dengan obat sejenis di formularium, estimasi jumlah pasien/tahun, harga per unit/satuan, serta nama & tanda tangan pengusul.**

Jika formulir tidak lengkap, sekretariat KFT berhak mengembalikan usulan sebelum masuk agenda rapat. Ini langkah sederhana tapi krusial: Anda menyaring masalah sejak awal, bukan di tengah rapat yang sudah mepet waktu.

Setelah form lengkap, jalankan alur kerja berikut:

1. **Registrasi dan verifikasi kelengkapan.** Sekretariat KFT mencatat tanggal terima, nama pengusul, dan kelengkapan dokumen. Usulan yang diterima maksimal H-7 sebelum rapat akan masuk agenda; selain itu dijadwalkan pada rapat berikutnya.
2. **Kajian teknis oleh subkomite evaluasi obat.** Subkomite (dokter, apoteker klinis, perawat) melakukan telaah cepat: adakah obat sejenis dengan indikasi sama yang sudah masuk formularium? Bagaimana profil efektivitas, keamanan, interaksi, stabilitas penyimpanan, dan ketersediaan di PBF lokal?
3. **Penyusunan lembar rekomendasi awal.** Apoteker menyiapkan ringkasan bukti, harga satuan, estimasi biaya per pasien per episode, dan dampak anggaran per tahun. Gunakan tabel sederhana agar mudah dibandingkan saat rapat.
4. **Pembahasan dalam rapat pleno KFT.** Setiap usulan diberi waktu presentasi maksimal 10 menit oleh pengusul (bisa diwakilkan), dilanjutkan diskusi 10 menit. Fokus pada tiga pertanyaan kunci: apakah obat ini mengisi kekosongan terapi? Apakah lebih unggul atau setara dengan obat existing? Apakah biaya sebanding dengan manfaat klinis?
5. **Pengambilan keputusan.** Gunakan pilihan: diterima tanpa syarat, diterima dengan syarat (misal hanya untuk indikasi tertentu atau unit tertentu), ditunda (butuh data tambahan), atau ditolak. Catat alasan keputusan secara eksplisit di formulir keputusan usulan—bukan hanya sekadar “disetujui” atau “ditolak”.

> ⚠️ **Penting: Setiap keputusan usulan obat baru wajib tercantum dalam notulen rapat KFT dengan format baku: nama obat, pengusul, ringkasan kajian, keputusan, alasan, dan tindak lanjut. Notulen ini adalah bukti telusur utama saat survei akreditasi PKPO, jadi jangan menunda pengisiannya.**

6. **Tindak lanjut pasca keputusan.** Jika diterima, masukkan obat ke formularium, perbarui SPO penggunaan obat terkait, sosialisasikan ke unit pelayanan, dan tentukan indikator pemantauan (misal: jumlah penggunaan per bulan,

efek samping yang muncul). Jika ditolak atau ditunda, sampaikan umpan balik tertulis kepada pengusul.

Untuk mempermudah, gunakan template Form Usulan Obat Baru (FUOB) yang memuat field berikut: identitas pengusul, data obat (generik, bentuk, kekuatan, kemasan), indikasi, alasan klinis, bukti literatur, perbandingan dengan obat existing, estimasi kebutuhan, harga, dan kolom rekomendasi subkomite. Simpan seluruh dokumen usulan dan kajian dalam satu folder elektronik per obat agar mudah ditelusuri.

Dengan alur dan form baku ini, evaluasi usulan obat baru tidak lagi bergantung pada ingatan atau lobi personal, melainkan pada data dan proses yang terdokumentasi.

INTI BAB: Evaluasi usulan obat baru yang objektif dan siap audit berawal dari form baku yang lengkap serta alur kerja bertahap dari verifikasi, kajian teknis, rapat pleno, hingga tindak lanjut. Dokumentasi setiap keputusan adalah kunci bukti telusur PKPO.

BAB 4

Proses Revisi dan Penghapusan Obat

Revisi formularium bukan sekadar “buang obat dari daftar.” Ini adalah cara KFT memastikan setiap obat yang tersedia masih punya alasan klinis, aman, tersedia, dan efisien. Mengacu Permenkes 6/2026 dan standar PKPO, revisi berkala bukan pilihan, melainkan keharusan. Penghapusan yang tertunda membuat formularium gemuk, membebani pengelolaan stok, dan menyulitkan dokter memilih terapi yang tepat.

Langkah-langkah berikut bisa dipakai sebagai alur baku revisi dan penghapusan obat.

1. **Tentukan kriteria penghapusan sejak awal.** Jangan menunggu rapat berdebat panjang. Gunakan checklist agar keputusan objektif dan bisa dipertanggungjawabkan saat akreditasi.

> ✅ **Checklist obat layak dihapus/direvisi:**
>
> - Tidak digunakan > 6–12 bulan berdasarkan laporan konsumsi.
> - Ada alternatif lebih aman atau setara dengan biaya lebih terkendali.
> - Muncul masalah keamanan baru, misalnya efek samping serius atau interaksi berisiko.
> - Pasokan tidak stabil atau sulit diperoleh.
> - Tidak lagi direkomendasikan oleh pedoman klinis/regulasi terbaru.
> - Mengalami duplikasi terapi dengan obat lain yang sudah terbukti lebih baik.
> - Sering kedaluwarsa karena peresepan rendah.

2. **Kumpulkan data pemakaian dan bukti klinis.** Minta instalasi farmasi menyiapkan laporan konsumsi 6–12 bulan terakhir, nilai sisa stok, jumlah kedaluwarsa, dan harga satuan. Sejajarkan dengan data efek samping atau kesalahan obat dari tim mutu. Obat yang terlihat murah, tetapi sering kedaluwarsa, justru lebih mahal karena biaya pengelolaan dan pemborosan.
3. **Lakukan telaah obat oleh tim kecil KFT.** Bentuk tim reviewer berisi apoteker, dokter spesialis terkait, dan perawat bila perlu. Gunakan form evaluasi penghapusan obat: nama obat, alasan penghapusan, alternatif terapi, risiko penghapusan, dan rekomendasi. Tim ini cukup menelaah 3–5 obat per siklus agar prosesnya tetap fokus.
4. **Uji dampak sebelum diputuskan.** Jangan hapus hanya karena satu SMF jarang memakai. Cek apakah ada unit atau kondisi khusus yang masih membutuhkan. Contoh: antihistamin generasi lama mungkin jarang digunakan, tetapi masih dibutuhkan untuk kondisi tertentu atau pasien dengan keterbatasan biaya. Minta masukan dari SMF pengguna terbesar dan unit gawat darurat.
5. **Bawa keputusan ke rapat pleno KFT.** Tim reviewer memaparkan hasil telaah, lalu rapat menetapkan status akhir: dihapus total, direvisi bentuk atau kekuatan sediaan, dibatasi indikasi, atau tetap dipertahankan dengan alasan khusus. Catat keputusan di notulen rapat sebagai bukti telusur.

> ⚠️ **Penting: Keputusan penghapusan harus terdokumentasi di notulen rapat, lengkap dengan alasan klinis dan alternatifnya. Bila akreditasi meminta bukti telusur, dokumen ini menunjukkan KFT bekerja sistematis, bukan asal menghapus obat.**

6. **Tetapkan masa transisi dan komunikasikan.** Umumkan keputusan kepada seluruh dokter penulis resep, farmasi, keperawatan, dan unit terkait. Berikan tenggat waktu, misalnya 30 hari, agar resep lama masih dapat

dilayani dan pasien kronis dialihkan ke alternatif. Pastikan obat pengganti sudah tersedia sebelum obat lama benar-benar dikeluarkan.

7. **Perbarui dokumen terkait.** Setelah masa transisi selesai, perbarui: daftar formularium, SPO penggunaan obat, e-resep/IFRS, label penyimpanan, dan form edukasi pasien. Ketidaksinkronan antara formularium dan SPO sering menjadi temuan akreditasi.
8. **Monitoring pasca-penghapusan.** Evaluasi 1–3 bulan setelah penghapusan: apakah ada keluhan kekosongan terapi? Apakah penggunaan alternatif meningkat wajar? Apakah muncul pembelian obat di luar formularium? Jika ya, lakukan revisi ulang pada siklus berikutnya.

Revisi dan penghapusan obat bukan proses sekali jalan. Jadikan kegiatan ini bagian dari rapat rutin KFT, misalnya setiap 6 bulan atau saat ada perubahan pedoman klinis. Dengan alur yang jelas, formularium tetap ramping, relevan, dan siap diuji akreditasi.

INTI BAB: Revisi dan penghapusan obat harus berbasis data pemakaian, telaah klinis, dan uji dampak—bukan sekadar memangkas daftar. Dokumentasikan setiap keputusan di notulen KFT agar formularium selalu sinkron dengan pelayanan dan bukti telusur akreditasi.

BAB 5

Menyinkronkan Formularium dengan SPO Penggunaan Obat

Formularium dan SPO penggunaan obat adalah dua sisi mata uang yang sama. Formularium menjawab *obat apa yang boleh dipakai*, sedangkan SPO menjawab *bagaimana obat itu dipakai dengan aman*. Jika keduanya tidak sinkron, yang terjadi di lapangan bisa begini: SPO perawat menyebut obat yang sudah tidak ada di formularium, sementara obat baru yang sudah masuk formularium tidak punya panduan pemberian. Akibatnya, terjadi kebingungan, risiko medication error, dan temuan saat akreditasi. Maka, tugas KFT bukan hanya menetapkan daftar obat, tetapi juga memastikan daftar itu hidup di dalam SPO unit pelayanan.

Berikut langkah konkret untuk menyinkronkan formularium dengan SPO penggunaan obat.

1. **Petakan semua SPO penggunaan obat yang aktif.** Minta instalasi farmasi dan tiap unit pelayanan mengumpulkan SPO yang memuat instruksi obat: SPO pemberian obat high alert, SPO pengelolaan narkotika, SPO pencampuran obat sitostatika, SPO pemberian insulin, dan sebagainya. Jangan lupa SPO di unit khusus seperti ICU, IGD, kamar bersalin.
2. **Buat tabel perbandingan sederhana.** Kolomnya: nama obat yang disebut di SPO, sediaan/kekuatan, tercantum di formularium? (Ya/Tidak), status tindak lanjut. Ini bisa dibuat di spreadsheet atau tabel manual. Yang penting mudah ditelusur dan diperbarui.
3. **Periksa obat di SPO yang tidak ada di formularium.** Untuk setiap obat yang muncul di SPO tapi tidak tercantum di formularium, tanyakan: apakah obat ini masih dipakai secara klinis dan memang dibutuhkan? Jika ya, segera ajukan melalui form evaluasi usulan obat baru (sudah dibahas di bab sebelumnya). Jika tidak, revisi SPO untuk mengganti obat tersebut dengan alternatif yang ada di formularium.
4. **Periksa obat di formularium yang belum punya SPO.** Tidak semua obat formularium butuh SPO khusus, tapi obat risiko tinggi (high alert, narkotika, sitostatika, elektrolit pekat) wajib punya SPO. Jika obat semacam ini masuk formularium, pastikan SPO pemberiannya sudah disusun dan disetujui sebelum obat didistribusikan ke unit.
5. **Libatkan petugas lapangan saat revisi.** Jangan sinkronisasi hanya di meja rapat KFT. Ajak kepala ruangan, perawat penanggung jawab, dan apoteker penanggung jawab unit untuk membaca draf perubahan SPO. Mereka yang tahu persis alur kerja harian dan bisa menangkap jika ada instruksi yang tidak realistis.

> **Tips: Gunakan matriks sederhana di spreadsheet bernama “Sinkronisasi Formularium-SPO”. Isi baris per obat, kolom untuk nomor SPO terkait, status sinkron (Ya/Tidak), dan tanggal verifikasi. Simpan di folder berbagi agar semua anggota KFT dan farmasi bisa mengakses. Ini sekaligus menjadi bukti telusur saat akreditasi.**

6. **Tetapkan jadwal sinkronisasi berkala.** Idealnya sinkronisasi dilakukan setiap kali ada revisi formularium (obat baru masuk, obat dihapus, atau perubahan kekuatan/sediaan) dan setiap kali ada revisi SPO. Minimal, lakukan audit sinkronisasi tiap 6 bulan sekali. Agenda ini bisa dimasukkan ke rapat rutin KFT.
7. **Dokumentasikan hasil sinkronisasi.** Setiap perubahan yang disepakati—baik revisi SPO maupun usulan perubahan formularium—harus dicatat dalam notulensi rapat KFT dan ditandatangani. Ini penting untuk

menunjukkan bahwa keputusan diambil secara sistematis, bukan dadakan.

✅ Checklist akhir sinkronisasi:

- ☐ Semua obat yang disebut dalam SPO unit pelayanan tercantum di formularium.
- ☐ Tidak ada SPO yang masih menyebut obat di luar formularium tanpa justifikasi tertulis.
- ☐ Semua obat high alert, narkotika, dan sitostatika di formularium punya SPO pemberian yang disetujui.
- ☐ Setiap obat baru yang masuk formularium sudah punya rencana SPO sebelum didistribusikan.
- ☐ Revisi SPO atau formularium terdokumentasi di notulensi rapat KFT.

Jika checklist di atas sudah terpenuhi semua, berarti formularium dan SPO di rumah sakit Anda sudah saling mendukung. Bukan lagi dua dokumen yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu sistem yang menjaga pasien dari risiko obat yang tidak terkendali.

INTI BAB: Sinkronisasi formularium dan SPO dilakukan dengan memetakan obat di SPO, membandingkannya dengan formularium, lalu merevisi salah satu atau keduanya secara berkala dan terdokumentasi sebagai bukti telusur akreditasi.

B A B 6

Dokumentasi Rapat dan Keputusan KFT

Dokumentasi rapat KFT sering jadi titik lemah saat akreditasi. Auditor tidak butuh notulen yang tebal berisi transkrip diskusi, tetapi butuh **jejak keputusan yang bisa ditelusur** dari usulan obat sampai tindak lanjut. Kabar baiknya, Anda bisa membangun kebiasaan dokumentasi rapi dengan dua dokumen sederhana: **notulen rapat** dan **keputusan KFT**.

Dua Dokumen Kunci

Pertama, **notulen rapat** menangkap proses diskusi dan alasan di balik keputusan. Kedua, **surat keputusan (SK) KFT** menangkap keputusan final yang mengikat. Notulen menunjukkan bahwa KFT bekerja secara kolektif dan berbasis data; SK menunjukkan bahwa keputusan itu resmi dan dapat dieksekusi.

Langkah Praktik: Template Notulen 1 Halaman

Buat format baku yang hanya mengisi poin-poin penting. Berikut template minimal yang bisa langsung dipakai:

1. **Header**
    - Nama komite: Komite Farmasi dan Terapi RS [Nama RS]
    - Nomor rapat: KFT-RAPAT/001/2025
    - Tanggal, waktu, tempat
    - Agenda utama
2. **Peserta rapat**
    - Tulis nama, jabatan, dan tanda tangan untuk anggota yang hadir.
    - Tandai yang tidak hadir dan alasannya.
3. **Bahan usulan yang dibahas**
    - Cantumkan satu tabel kecil: nomor usulan, nama obat/isu, pengusul, lampiran (form evaluasi, bukti ilmiah, data penggunaan).
4. **Ringkasan diskusi per agenda**
    - Cukup 3–5 kalimat per agenda: fokus pada data yang dibahas, pendapat berbeda, dan kesimpulan.
    - Contoh: *“Usulan obat A: data penggunaan 6 bulan menunjukkan 120 pasien membutuhkan alternatif karena stok obat lama sering kosong. Anggota menyetujui dengan syarat monitoring efek samping 3 bulan pertama.”*
5. **Keputusan rapat**
    - Tulis keputusan dengan kata kerja operasional: disetujui, ditunda, ditolak, direvisi.
    - Contoh: *“Obat A disetujui masuk formularium kategori obat baru dengan evaluasi ulang 3 bulan.”*
6. **Tindak lanjut**
    - Buat kolom: tindakan, penanggung jawab, tenggat.
    - Contoh: *“Sekretaris KFT menerbitkan SK penambahan obat A, distribusi ke farmasi dan instalasi terkait, paling lambat 7 hari kerja.”*
7. **Tanda tangan**

- Ketua dan sekretaris KFT menandatangani notulen pada rapat berikutnya setelah disetujui.

> **Tips: Simpan notulen dalam format 1 halaman per rapat. Jika rapat panjang, pecah per agenda dalam lampiran, tapi halaman utama tetap ringkas. Auditor akan cepat menemukan keputusan tanpa membaca puluhan halaman.**

Langkah Praktik: Format Keputusan KFT

Setiap keputusan yang mengubah formularium perlu dituangkan dalam SK singkat. Format minimal:

```
KOP RS
SURAT KEPUTUSAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
Nomor: 445/SK-KFT/12/2025

Tentang: Penambahan Obat [Nama Obat] ke Dalam Formularium RS

Menimbang: Hasil rapat KFT tanggal [tanggal] nomor [nomor notulen].
Memutuskan:
1. Obat [nama generik, sediaan, kekuatan] masuk formularium kategori [kategori].
2. Berlaku mulai [tanggal] dengan evaluasi ulang [waktu].
3. [Jika perlu] Hapus obat lama yang digantikan.

Ditetapkan di: [kota]
Tanggal: [tanggal]
Ketua KFT,          Sekretaris KFT,

[Nama dan NIP]      [Nama dan NIP]
```

Satu SK hanya untuk satu keputusan utama agar mudah diindeks dan ditelusur.

Langkah Praktik: Simpan dan Susun Arsip

- Buat folder per tahun, misal *“Arsip KFT 2025”*.
- Di dalamnya pisahkan subfolder: Notulen, SK, Usulan Obat Masuk, Usulan Obat Keluar, Laporan Evaluasi.
- Beri penomoran berurutan pada setiap dokumen.
- Scan atau simpan versi digital; simpan juga hardcopy untuk tanda tangan basah.

> **Checklist bukti telusur rapat KFT saat akreditasi:**
>
> Notulen rapat minimal 2 kali setahun (atau sesuai kebijakan RS)
> Daftar hadir bertanda tangan
> SK penetapan formularium dan perubahannya
> Bukti distribusi SK ke unit farmasi, instalasi, dan komite medik
> Form evaluasi usulan obat baru yang sudah terisi
> Notulen evaluasi obat yang dihapus beserta alasan data penggunaan

Dengan dua dokumen sederhana ini, dokumentasi KFT tidak lagi menjadi beban, melainkan bukti kuat bahwa formularium dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

INTI BAB: Dokumentasi rapat KFT cukup dua jenis dokumen—notulen 1 halaman yang menangkap proses dan SK yang menangkap keputusan final. Simpan dengan indeks rapi agar setiap keputusan formularium bisa ditelusur dari usulan sampai tindak lanjut saat akreditasi.

B A B 7

Menyiapkan Bukti Telusur PKPO untuk Surveyor

Saat surveyor akreditasi masuk ke ruangan KFT, mereka tidak akan sekadar bertanya, “Formulariumnya sudah diperbarui, kan?” Mereka akan meminta bukti fisik, menelusuri dokumen, dan mencocokkan isi formularium dengan SPO serta praktik di lapangan. Di sinilah banyak KFT panik: dokumen ada tapi berantakan, atau ada kegiatan tapi tidak terdokumentasi. Bab ini akan membantumu menyusun bukti telusur PKPO yang rapi, lengkap, dan siap ditunjukkan kapan pun.

Dokumen yang paling sering diperiksa surveyor PKPO:

1. **SK Pembentukan KFT** — lengkap dengan struktur, nama anggota, dan masa berlaku. Pastikan SK terbaru, bukan SK lama yang sudah kedaluwarsa.
2. **Formularium RS yang berlaku** — bukan draf, bukan versi lama. Cantumkan tanggal penetapan dan tanda tangan pihak berwenang (direktur atau ketua KFT).
3. **Riwayat revisi formularium** — bisa berupa tabel log perubahan: item obat yang ditambah/dihapus, alasan, tanggal, dan nomor SK/berita acara.
4. **Notulensi rapat KFT** — terutama rapat evaluasi obat baru, penghapusan obat, dan review formularium berkala. Notulensi harus memuat: tanggal, peserta, agenda, keputusan, dan tindak lanjut.
5. **Form evaluasi usulan obat baru** — format baku yang dipakai untuk menilai obat yang diusulkan dokter spesialis. Jangan hanya ada form kosong; harus ada contoh isian sebagai bukti pernah digunakan.
6. **SK atau berita acara penghapusan obat** — untuk obat yang sudah tidak relevan. Dokumen ini sering ditanyakan karena membuktikan formularium memang direview, bukan sekadar ditambah terus.
7. **Matriks kesesuaian formularium dengan SPO penggunaan obat** — tabel sederhana yang memetakan: obat dalam formularium → SPO terkait → unit pelayanan yang menggunakan. Ini menjawab tuntutan PKPO tentang sinkronisasi.
8. **Bukti distribusi formularium** — tanda terima atau email pengiriman ke unit pelayanan (IGD, rawat inap, rawat jalan, OK, dsb). Foto atau scan bukti serah terima jauh lebih kuat daripada sekadar klaim “sudah dibagikan”.
9. **Laporan monitoring kepatuhan penggunaan formularium** — misalnya persentase peresepan obat sesuai formularium per bulan. Bisa berupa rekap dari instalasi farmasi.

Langkah praktik menyiapkan bukti telusur:

1. **Buat checklist dokumen PKPO** dalam satu spreadsheet. Kolom: Nama Dokumen, Penanggung Jawab, Tanggal Terakhir Update, Lokasi Penyimpanan, Status (Lengkap/Kurang). Isi minimal sebulan sebelum jadwal survei.
2. **Kumpulkan dan pindai semua dokumen fisik** ke format PDF. Simpan dalam folder digital dengan penamaan jelas, contoh: `2025-03-14_Notulensi_Rapat_KFT_Evaluasi_Obat_Baru.pdf`.
3. **Buat satu binder fisik master** berisi salinan semua dokumen di atas, urut sesuai checklist. Binder ini akan memudahkan surveyor dan menunjukkan kesiapan tim.
4. **Uji telusur internal** — minta salah satu anggota KFT (bukan yang menyiapkan) berpura-pura menjadi surveyor. Minta dokumen tertentu, misalnya “Tunjukkan bukti penghapusan obat X tahun lalu.” Jika dalam 2 menit dokumen tidak ditemukan, artinya penyimpanan masih perlu dirapikan.
5. **Buat daftar tautan silang** — di setiap notulensi rapat, tambahkan catatan kecil: “Terkait: Form Evaluasi Obat

Baru No. 014, SK Penetapan No. 045/KFT/III/2025.” Ini memudahkan surveyor menelusuri benang merah kegiatan.

Catatan: Surveyor PKPO sering melakukan “telusur silang” — mereka mencocokkan notulensi rapat, SK penetapan, formularium yang beredar di bangsal, dan SPO yang dipakai perawat. Jika satu saja tidak sinkron (misalnya formularium versi bangsal berbeda dengan versi di KFT), temuan akan muncul. Pastikan versi terbaru terdistribusi dan ditarik semua versi lama.

Contoh nyata saat survei: surveyor meminta bukti evaluasi usulan obat baru dari dokter spesialis. Kamu tunjukkan tiga hal sekaligus: (1) form evaluasi usulan yang terisi lengkap dengan skor dan rekomendasi, (2) notulensi rapat yang membahas usulan tersebut, dan (3) SK penetapan obat masuk formularium. Jika tiga dokumen itu tersaji rapi dan konsisten, surveyor akan cepat berpindah ke elemen lain.

Tips: Simpan softcopy semua dokumen di cloud drive (Google Drive/SharePoint) dan beri akses ke seluruh anggota KFT. Saat survei, siapa pun bisa mengambil file dalam hitungan detik meski binder fisik sedang dipakai surveyor lain. Jangan lupa atur permission “view only” agar tidak ada yang tidak sengaja mengedit.

Dokumen yang lengkap tapi tidak terawat sama buruknya dengan tidak ada dokumen. Jadwalkan 30 menit setiap awal bulan untuk memeriksa checklist, memperbarui log perubahan, dan memastikan tidak ada notulensi yang belum ditandatangani. Bukti telusur PKPO bukan pekerjaan dadakan seminggu sebelum survei; ia dibangun dari kebiasaan dokumentasi harian KFT.

INTI BAB: Siapkan sembilan dokumen inti PKPO secara rapi dan konsisten, lalu uji ketelusuran internal secara berkala. Bukti telusur yang kuat lahir dari dokumentasi rutin, bukan dari panik menjelang akreditasi.

BAB 8

Evaluasi Tahunan Formularium RS

Evaluasi tahunan formularium itu bukan sekadar formalitas biar dokumen akreditasi PKPO terpenuhi. Ini momen kamu dan tim KFT “reset otak”: obat mana yang masih layak dipertahankan, mana yang sudah waktunya disingkirkan, dan mana yang perlu masuk karena kebutuhan klinis berubah. Kalau proses ini asal jalan, formularium RS akan jadi dokumen mati yang makin jauh dari praktik sehari-hari.

Masalahnya, banyak KFT bingung mulai dari mana. Padahal kuncinya satu: **evaluasi harus berbasis data, bukan opini**. Berikut langkah praktis menyusun laporan evaluasi tahunan formularium yang bisa langsung kamu tiru di RS.

Langkah 1: Kumpulkan Data Penggunaan Obat Setahun Penuh

Minta bagian farmasi atau IFRS menarik data penggunaan obat selama periode evaluasi (misal Januari–Desember). Data minimal yang kamu butuhkan:

1. **Daftar obat formularium beserta jumlah pemakaian** (satuan unit, vial, tablet, dll).
2. **Nilai belanja per item obat** (rupiah total dan tren per kuartal).
3. **Obat yang tidak bergerak (stagnan)** selama 6–12 bulan terakhir.
4. **Kejadian obat kedaluwarsa atau hampir kedaluwarsa** di gudang farmasi.
5. **Data peresepan obat di luar formularium** (off-formularium) yang sering muncul, lengkap dengan alasan dokter peresep.

Dari data ini kamu sudah bisa melihat pola: obat mana yang jadi beban biaya tapi jarang dipakai, obat mana yang sering diminta padahal belum masuk daftar.

> **Tips: Jangan hanya lihat total pemakaian. Obat yang dipakai banyak tapi dengan nilai kecil bisa jadi lebih penting daripada obat mahal yang jarang dipakai. Selalu kaitkan data pemakaian dengan outcome klinis jika tersedia, misalnya dari rekam medis atau laporan kasus.**

Langkah 2: Hitung Kepatuhan Formularium

Kepatuhan terhadap formularium adalah indikator wajib yang sering ditanya saat akreditasi. Cara menghitungnya sederhana:

- Ambil sampel resep atau e-resep dari unit rawat inap dan rawat jalan selama setahun (misal 100–300 resep per unit).
- Hitung persentase item obat yang termasuk dalam formularium RS.
- Jika angka kepatuhan <80%, cari tahu penyebabnya: apakah formularium kurang lengkap, obat sulit didapat, atau dokter tidak tahu obat yang tersedia.

Contoh nyata: RS Tipe C menemukan kepatuhan formularium di poli penyakit dalam hanya 72%. Setelah ditelusuri, ternyata 3 obat antihipertensi yang sering diresepkan dokter spesialis jantung belum masuk formularium karena usulan obat baru dari dua tahun lalu tidak pernah dievaluasi. Akibatnya dokter terpaksa meresepkan off-formularium, dan farmasi selalu “kejar-kejaran” menyediakan obat tersebut secara dadakan. Solusinya: tim KFT memasukkan ketiga obat itu dalam usulan revisi formularium tahun berikutnya.

Langkah 3: Tinjau Masalah Keamanan dan Mutu Obat

Minta laporan dari Tim Keselamatan Pasien atau Komite Mutu tentang:

- Efek samping obat (MESO) yang terkait obat formularium.
- Medication error yang melibatkan obat formularium (misal kesalahan pemberian karena kemasan mirip).
- Laporan obat substandar atau produk yang sering komplain dari perawat/dokter.

Obat dengan catatan keamanan buruk atau laporan mutu tidak konsisten harus masuk daftar evaluasi khusus. Jangan ragu mencoret obat yang secara klinis bermasalah meskipun harganya murah.

Langkah 4: Identifikasi Kandidat Penghapusan

Buat kriteria objektif untuk obat yang layak dihapus:

- Tidak digunakan sama sekali dalam 12 bulan terakhir (atau 6 bulan untuk RS dengan perputaran cepat).
- Ada alternatif dalam formularium dengan efektivitas sama tetapi biaya lebih rendah atau profil keamanan lebih baik.
- Terbukti tidak efektif berdasarkan bukti ilmiah terbaru (misal sudah tidak masuk pedoman nasional).
- Supplier tidak mampu menyediakan secara konsisten, menyebabkan kekosongan berulang.

Setiap calon obat hapus harus disertai alasan tertulis dan data pendukung, bukan sekadar “sudah jarang dipakai”.

Langkah 5: Susun Laporan Evaluasi Tahunan

Format laporan tidak perlu rumit, yang penting bisa ditelusuri. Gunakan struktur berikut:

1. **Ringkasan eksekutif** – maksimal 1 halaman berisi temuan utama dan rekomendasi.
2. **Data penggunaan obat** – tabel rekap 10 obat terbesar, 10 obat terkecil, serta obat stagnan.
3. **Kepatuhan formularium** – angka persentase per unit, lengkap dengan analisis penyebab jika di bawah target.
4. **Laporan keamanan dan mutu** – ringkasan MESO, medication error, dan keluhan mutu.
5. **Usulan perubahan** – daftar obat masuk, obat keluar, obat pengganti, lengkap dengan justifikasi klinis dan finansial.
6. **Lampiran** – form evaluasi obat baru yang tertunda, notulensi rapat KFT sepanjang tahun, serta SPO terkait.

> ✅ **Checklist sebelum laporan dibawa ke rapat pleno KFT:**
>
> - ☐ Semua data penggunaan sudah diverifikasi oleh bagian farmasi.
> - ☐ Setiap usulan obat masuk/hapus memiliki form evaluasi lengkap.
> - ☐ Dokumen pendukung (MESO, notulensi, SPO) sudah dilampirkan.
> - ☐ Rekomendasi sudah dikaitkan dengan indikator mutu PKPO.
> - ☐ Draft laporan sudah dibaca minimal oleh ketua dan sekretaris KFT.

Langkah 6: Presentasikan dan Tindak Lanjuti

Bawa laporan ini ke rapat pleno KFT yang dihadiri direktur medik, kepala farmasi, ketua komite medik, dan perwakilan SMF. Setelah disetujui, jangan lupa:

- Perbarui dokumen formularium resmi RS dan distribusikan ke semua unit.

- Sinkronkan dengan SPO penggunaan obat yang ada.
- Arsipkan laporan evaluasi tahunan sebagai bukti telusur akreditasi.
- Jadwalkan monitoring kepatuhan formularium di kuartal pertama setelah revisi untuk melihat efek perubahan.

Dengan siklus ini, formularium RS kamu tidak akan jadi dokumen pajangan. Ia hidup, diperbarui berdasarkan kebutuhan nyata, dan siap dipertahankan di hadapan asesor.

INTI BAB: Evaluasi tahunan formularium harus berbasis data penggunaan, kepatuhan, dan keamanan obat—bukan opini—lalu dituangkan dalam laporan terstruktur sebagai dasar revisi formularium berikutnya agar PKPO terpenuhi dan praktik klinis tetap relevan.